

Perte de sang P1

Source de saignement :

- Epistaxis
- Méléna, rectorragie, hématochésie
- Hémoptysie
- Ménorragie, hyperménorrhée
- Hématurie
- Trauma
- Trouble de la crase

Tr. de la crase

Quantifier grandeur des ecchymoses, gingivorragie (brossage des dents), hémarthrose, pétéchies, anamnèse familiale (garçons, filles ?), OH, insuffisance hépatique, chute sur la tête ?, hématurie, hémoptysie, épistaxis, sang dans les selles, cycles menstruels, nombre de tampons/jour, histoire obstétricale (accouchement, fausses couches), grossesse, symptômes d'anémie (palpitations, dyspnée d'effort, pâleur), infection récente, symptômes B (fièvre, perte de poids, sudations nocturnes), douleurs abdominales, diarrhées/constipation, N/V

DD:

- Hémophilie A et B
- Maladie de Von Willebrand
- Insuffisance hépatique
- Insuffisance rénale
- Thrombopénie
- Déficit en vit.K (apport insuffisant, malabsorption)

Exa: TR, palper foie et rate (hypersplénisme, hypertension portale), inspecter extrémités, téguments, auscultation cardio-pulmonaire

Work-up: FSC, TP/aPTT

Prise de poids P2

Depuis quand ? combien de kg ? chgt de régime ? événement particulier, surpoids dans la famille, médicaments (neuroleptiques), stop tabac, prise de corticoïdes systémiques ou topique (crème!!), TA trop élevée, diabète (polydipsie, polyurie,...), maladie de Cushing (baisse de la libido, aménorrhée, polyurie, douleurs osseuses dues à l'ostéoporose, mauvaise cicatrisation, faiblesse musculaire proximale, douleur abdominale, colique néphrétique, céphalée, dépression), opérations (immobilisation ?), dentiste ?, femme enceinte, syndrome néphrotique, ascite, insuffisance cardiaque, FRCV, travail de nuit, hypothyroïdie (fatigue, constipation, voix rauque, aménorrhée, frilosité, sécheresse cutanée, atrophie musculaire, perte de libido), poids adolescence, anorexie, dyspnée, syndrome d'apnée du sommeil (ronflements), cycles menstruels, hirsutisme, exercices

DD :

- dépression
- stress
- maladie de Cushing (HTN, obésité centrale, faciès lunaire, bosse de bison, empatement sus-claviculaire, vergetures pourprées)
- hypercorticisme (corticothérapie au long court)

- ascite (cancer ovaire, insuffisance hépatique/cardiaque, syndrome néphrotique)
- hypothyroïdie
- syndrome d'apnée du sommeil
- syndrome des ovaires polykystiques

Exa: poids, tour de taille, taille, signe du glaçon/flot, cœur, poumon, OMI, hypothyroïdie (palper thyroïde, réflexes, pulsations,...)

Work-up: cortisol libre urines de 24h + cortisol salivaire à 23h, test de suppression Dexaméthasone

Perte de poids P3

Quantité, durée, intentionnel, symptômes B (perte de poids, sudation nocturne, fièvre), Tbc (toux, comptage, sym.B, voyages, vaccination, tt immunosuppresseur), douleurs abdominales, stéatorrhée, malabsorption (caca qui flotte, gaz, diarrhées), parasitose, alternance diarrhée/constipation, médicaments (laxatifs, phytothérapie,...), chirurgie, hyperthyroïdie (tremor, palpitations, transpirations, diarrhée,...), anorexie (aménorrhée, image de soi/du corps, idées suicidaires), dépression (insomnie,...), douleurs articulaires, lésions cutanées, myalgies, prothèses dentaires, abcès dentaire, candidose, amphétamines, HIV, hépatite, RCUH/Crohn

Exa: muqueuse buccale, poids, taille, signes vitaux, tremor, état d'hydratation, pli cutané, temps de recoloration, palper thyroïde, TR

DD :

- néoplasies
- hyperthyroïdie
- Tbc
- stress
- anorexie
- dépression
- malabsorption
- médicaments

Work-up: TSH, FSC, électrolytes, anticorps HIV, Toxscreen

Perte d'appétit P4

Stress, anorexie, dépression, situation sociale, état inflammatoire (fièvre ?, parasitose, Tbc,...), néoplasies (symptômes B), OH, tabac, dysphagie, RGO, arthralgies

Fatigue P6

Matinale, vespérale, nombre d'heure de sommeil, apnées, ronflement, sommeil réparateur, le week-end, la semaine, insomnies, ruminations, habitude alimentaire, café, OH, médicaments, hygiène, atcd, grossesses, opérations chirurgicales, somnolence diurne, dysesthésie des jambes ou inconfort, chgt de vision, performance, tristesse, idées suicidaires, symptômes d'hypothyroïdie, relations sexuelles à risque, syndrome de fatigue chronique (tr. de la mémoire ou de la concentration, mal de gorge, ADP douloureuse, myalgies, polyarthralgies, céphalées, sommeil non réparateur, sensation de malaise après l'effort durant > 24h)

Exa: ADP, hépatosplénomégalie, ictère, cyanose, palper thyroïde, status ostéo-articulaire, dyspnée, tachycardie, hypoTA, status neuro, TR

DD :

- néoplasies (cancer colon)
- hypothyroïdie
- syndrome d'inflammatoire, connectivites, HIV
- maladie coeliaque
- Hépatites virales (A,B,C) et non-virales
- syndrome d'apnée du sommeil
- syndrome des jambes sans repos
- tr. anxieux, dépression
- sédatifs/somnifères
- OH/caféine/tabac
- mononucléose

Work-up: FSC, TSH, polysomnographie, VS, ASAT/ALAT, ferritine, test de grossesse, test HIV, créatinine

Lymphadenopathy P9

DD : hémopathies malignes, Tbc, HIV, HSV, EBV, parasitoses

Questions type : molle, dur, unique, multiple, où, depuis quand ?, fièvre, perte de poids, prurit, sudations, douloureux, fixe/mobile, animaux domestiques/parasites (voyages, chat), métier, VIH, Tbc, immunosuppression, EBV (dysphagie), IST (dysurie, algurie, hématurie, chancre mou), leucémies (saignements), toxoplasmose, CMV

Examen clinique : TOUTES les aires gg, conjonctive, fond de gorge (pharyngite, candidose, leucoplasie chevelue), hépatosplénomégalie, T°, TA, ...

Fever P10

DD : néoplasie, infectieux, vasculaire, intoxication (syndrome sérotoninergique), médicaments.

Questions types : à combien ?, cyclique, sudations, perte de poids, céphalées, photophobie, N/V, odynodysphagie, toux/crachats, dyspnée, rash, diarrhées, hématurie, arthralgies, factice ?, médicaments, AVC, crise d'épilepsie, voyage, comptage,

Examen clinique : T°, poids, TA, état d'hydratation,

Fièvre chez l'immunosupprimé P11

DD : infection fongique (candidase, aspergilus), sepsis, listeriose (lait non pasteurisé), Tbc (voyage, contag), CMV, pneumocystis jiroveci (toux sèche).

Examen clinique : PAS DE TR (risque de sepsis)

Complet ! cœur, poumon, abdo, neuro (raideur de nuque, n. crânien), catheter, loges rénale, organes génitaux, adénopathies, palper la colonne.

Prise en charge : hémoc, Rx thorax, culture expecto, culture urine.

Hypothermie P12

DD : coma d'hypothyroïdie, toxique, température ambiante.

Anamnèse : orientation, Glasgow, prise de substance,

Examen clinique : status mental, neuro, trace d'injection, réflexe diminué, bradypnée, diurèse augmentée, status cardio-pulm, état d'hydratation, pouls, gelure ?

Labo : FSC, électrolyte, glycémie, créat, urée, ASAT, ALAT, diminution du fibrinogène avec risque de CIVD, myoglobine dans urine, dépistage des toxines.

ECG (onde d'Osborn)

Prise en charge : Si stable, réchauffement passif : couverture, température ambiante. Si instable : perf. chaude, oxygène réchauffé

Hyperthermie P13

DD : hyperthermie maligne, crise thyrotoxisque, syndrome malin des neuroleptique, phéochromocytome, surchauffement iatrogène, sepsis, intoxic (cocaïne, exta), encéphalopathie hypoxique, coup de chaleur.

Anamnèse : médic (hormone thyroïdienne), drogue,

Examen clinique : tachycardie, rigidité musculaire, saturation, contracture musculaire

Labo : gaso (hypercapnie, acidose mixte), hyperkaliémie, hypercalcémie, myoglobine, CK, ECG, risque de CIVD (dim. fibrinogène).

Sudation anormale P14

DD : Infectieux (tbc,), ménopause (règle, hormone de substitution, contrôle gynéco, bouffée de chaleur, changement d'humeur, perte de libido, sécheresse vaginale, douleur articulaire, insomnie, nausée, urgence mictionnelle, prurit vaginale, fatigue, irritabilité, mémoire), psy (attaque de panique, angoisse associée), néoplasie (sein,), endocrinologie (hyperthyroïdie, phéo (céphalée, palpitation, transpiration)), hypoglycémie, hypotension. Idiopathique, médicament (amphét, neuroleptique, hormone thyroïdienne).

Anamnèse : quand, combien, où, symptôme associé, perte de poids, fièvre, toux, dyspnée, crachat, comptage, voyage, chimiothérapie, médicament,

Flushing P15

DD : ménopause

Polydypsie P16

DD : diabète insipide, hypercalcémie, psy (ne se lève pas la nuit), chaleur, alcool, médicament, intoxication Vit D.

Anamnèse : hypercalcémie (lithiase, confusion, trouble psy, hyperparathyroïdisme, tumeur, immobilisation, sarcoïdose),

Status : neuro, réflexe,

Labo : Osmolalité urinaire/sanguine, spot, glucose sanguin, électrolytes (ph, Mg), ECG (raccourcissement du QT)

Déshydratation P17

DD :

Exa : 3^{ème} secteur

Labo :

Mort inexpliquée P18

DD : mort subite du nourrisson, fibrillation ventriculaire, syndrome du bébé secoué

Hyperglycémie P19

DD : Médic (cortisol, thiazide, b-bloquant), infection, sepsis, polytrauma, brûlure, hypoxie, opération.

Anamnèse : polyurie, polydipsie, douleur abdo, changement régime, faiblesse, perte de poids, nausée, vomissement, confusion, perte de connaissance, crise d'hypo (céphalée, trouble visuelle, tremblement, trouble de l'humeur, perte de connaissance)

Labo : créat

Hypoglycémie P20

DD : sport, alcool, changement site d'injection, glynide, sulfamidé, AINS, b-bloquant, aspirine, ATCD d'hypo non ressentie

Anamnèse : Céphalée, trouble visuelle, tremblement, trouble de l'humeur, perte de connaissance, transpiration, tachycardie, faim.

Calcium, Phosphate P21

Hypocalcémie : chirurgie thyroïdienne, carence en Ca ou Vit D, insuf réanle, biphosphonate, attention médic.

Status : chvostek (n. facial sous arcade zygomatique), trousseau (tension 10mmHg au dessus systolique, 4 min et main d'accoucheur), hypereflexie, tétanie, rabdomyolyse, ECG (QT long)

Labo : albumine

Phosphate : malnutrition, anorexie, confusion

Hyperlipidémie P23

Anamnèse : FR tabac, alcool, anamnèse familiale, antécédent, tension artérielle, HDL, triglycéride, prise de pilule, médicaments.

Alcool

Style de vie : activité physique, diminution graisse saturée, régime riche en fibre, perte poids, stop tabac.

Pâleur P34

DD : Anémie (onco,), emphysème, intoxication, médicament (chimio), insuf. Rénale, coeliakie, diabète.

Anamnèse : perte de sang, adénopathie, perte de poids, transpiration nocturne,

Ictère ?

Prurit P43

DD : peau sèche, choléstase, diabète, SEP, opioïdes, aspirine, néoplasies (Hodgkin, PV), grossesse, parasitoses (gale, poux, lamblia), hyperthyroïdie, hypothyroïdie, psychogène (angoisse), pilule contraceptive, hépatite C

Questions type : localisation localisé vs généralisé, depuis quand, la nuit/le jour, lésions dermatologiques, facteurs aggravant (eau, chaud, froid, solvantss), voyage, prise d'AB, relation sexuelle, grossesse, hydratation de la peau, perte de poids, T°, sudations nocturnes, ictère, douleurs abdominales, allergie, crème, cosmétiques,

Exa : ADP, lésions cutanées/excoriations, Murphy, Courvoisier (cholangiocarcinome, cancer pancréatique), hépatosplénomégalie, palper la thyroïde, CV/pulm, signer Koebner, dermatographisme (blanc)

Otalgie P68

Début, progression, irradiation, ADP, facteurs améliorant/aggravant, otorrhée, rougeur, prurit, hypoacousie, hyperacousie, vertiges, sensation de plénitude de l'oreille, acouphènes, infection récente, fièvre, toux, rhinorrhée, piscine, corps étranger, cérumen, Q-tips, dysphagie, trauma (barotraumatisme -> plongée, avion, perforation du tympan), atcd otite, DM

DD:

- Otite moyenne
- Otite externe
- Herpes zoster oticus
- Choléstéatome
- Folliculite/cellulite du conduit auditif externe
- Douleur référée (angine, trachéite, thyroïdite, ATM, dents, néoplasies cavité buccale)

Exa: otoscopie, fond de gorge, ADP, percussion mastoïde, mobilisation tragus/pinna, Rinné/Weber

Perte d'audition P70

Début, progression, localisation, intensité, unilatéral vs bilatéral, facteurs aggravants/améliorant, sons aigus et graves ou spécifique à certains sons, problème à comprendre les gens, otalgie, sensation de plénitude de l'oreille, otorrhée, acouphènes, infection récente, fièvre, vertiges, N/V, corps étranger/cérumen, céphalées, trauma tête, traumatismes acoustiques (travail?, concerts,...), grossesse, prise de médicaments, voyage récent

DD:

- Presbyacousie
- Neurinome de l'acoustique
- Infectieux (otite moyenne/externe, labyrinthite, névrite vestibulaire,...)
- Corps étranger, impaction de cérumen
- Trauma (perforation du tympan, fracture du rocher, acoustique)
- Cholestéatome
- Otosclérose
- Médicaments ototoxiques (diurétique de l'anse, aminoglycosides, AINS, antimalarique,...)

Exa: otoscopie, fond de gorge, ADP, percussion mastoïde, mobilisation tragus/pinna, Rinné/Weber, test à la voix chuchotée, nerfs crâniens, force/sensibilité, réflexes, épreuves cérébelleuses

Work-up: audiométrie, impédance

Tinnitus P71

Début, progression, unilatéral vs bilatéral, pulsatilité, facteurs aggravants/améliorant, otalgie, sensation de plénitude de l'oreille, otorrhée, infection récente, fièvre, vertiges, N/V, corps étranger/cérumen, céphalées, trauma tête, traumatismes acoustiques (travail?, concerts,...), grossesse, prise de médicaments, voyage récent

DD:

- Infectieux (otite moyenne aiguë, mastoïdite, labyrinthite)
- Tumeur du glomus (tinnitus pulsatile, perte d'audition, masse bleutée derrière le tympan)
- Maladie de Menières
- Souffles vasculaires (dissection carotides, malformations artério-veineuse,...)
- Neurinome de l'acoustique
- Traumatisme acoustique
- Otosclérose
- Médicaments (AINS, furosémide, aminosides,...)

Exa: otoscopie, fond de gorge, ADP, percussion mastoïde, mobilisation tragus/pinna, Rinné/Weber, test à la voix chuchotée, nerfs crâniens, force/sensibilité, réflexes, épreuves cérébelleuses

Work-up: US des carotides, IRM

Epistaxis P72

Causes locales

- Trauma, trauma digital, corps étranger
- Chimique (cocaïne, spray vasoconstricteur, poussière bois)
- Sécheresse nasale (air conditionnée, déformation septum)
- Tumeur, polype, carcinome épidermoïde (métier (bois, textile), tabac, pollution, rhinosinusite chronique)
- Inflammation, rhinite allergique, non-allergique, bactérien, fongique

Causes systémiques

- HTA
- Artérosclérose
- Osler-Weber-Rendu (triade -> télangiectasie, anamnèse familiale positive, épistaxis spontané)
- Coagulopathie (hémophilie, Von Willebrand, maladie rénale et hépatique, AINS, anticoagulant, hémopathie maligne)
- LED, Wegener (ORL, poumon, glomérulonéphrite)

Dépression

- Humeur dépressive
- Anhédonie
- Tr. sommeil (insomnie, hypersomnie)
- Prise ou perte de poids (appétit diminué ou augmenté)
- Diminution d'énergie/fatigue
- Ralentissement ou agitation psychomotrice
- Concentration
- Culpabilité
- Risque suicidaire :

Questions explicite: «avez-vous été assez découragé pour avoir envie de mettre fin à vos jours»

FR: âge, sexe, troubles psychiatriques et somatiques, abus de substance, impulsivité et conduite à risque, atcd personnels et familiaux, facteurs psychosociaux

Degré d'urgence: imminence de la conduite suicidaire, degré d'élaboration du scénario suicidaire (où, quand, comment)

Dangerosité: létalité et accessibilité du moyen

Ressources disponibles

Sentiment de toute puissance, idées accélérées, augmentation des dépenses, comportement sexuel à risque, agitation, logorrhée, investissement dans activités récréatives mais avec des conséquences dommageables)

Début, événement particulier, durée, OH, médicaments, abus de substances, stress, fonctionnement social et répercussion, anamnèse familiale de tr. de l'humeur, épisodes antérieurs, réveils matinaux, comportement à risque (mutilation, relation sexuelle, drogues), changement de travail

Exa: - paramètres vitaux, exa tête et cou, exa neuro, status mental (orientation, attention/concentration, mémoire)

Work-up: - exa physique, status mental, TSH, FSC, toxscreen, alcoolémie

DD: tr. de l'adaptation avec humeur dépressive, épisode dépressif majeur, tr. schizoaffectif, tr. bipolaire I/II, tr. cyclothymique

Psychose

- Symptômes positifs: hallucinations (auditives, tactiles, olfactives, visuelles), pensée désorganisée, comportement désorganisé/catatonique
- Symptômes négatifs: affect émoussé, retrait social, diminution motivation, diminution discours/pensée
- Symptômes cognitifs: discours désorganisé, paranoïa
- Episodes antérieurs, hospitalisation antérieure, début maladie psychiatrique
- Psychomotricité
- Médicaments, psychotropes, OH, abus de substances
- Problème judiciaire
- Sentiment de toute puissance, idées accélérées, augmentation des dépenses, comportement sexuel à risque, agitation, logorrhée, investissement dans activités récréatives mais avec des conséquences dommageables)
- Attention/concentration
- Tr. du sommeil
- Tr. du moi (sensation d'étrangeté, de déréalisation, ...)
- Tr. de l'affect (dépression, anxiété, ...)
- Capacité d'insight (avez-vous l'impression de souffrir d'une maladie psychiatrique, pourquoi prenez-vous ces médicaments, pourquoi êtes-vous hospitalisé?)

Exa: - paramètres vitaux, status mental (orientation, mémoire, idées suicidaires -> urgences, dangerosité, FR)

Work-up: - Toxscreen, TSH, FSC, électrolytes, créatinine, ASAT/ALAT, ECG (QT long)

DD: schizophrénie, personnalité schizoïde, tr. psychotique induit par substances ou maladie somatique, dépression avec syndrome psychotique

Perte de cheveux P54

DD : malnutrition (anorexie), déficit en fer, médicaments (pilule contraceptive), dermatite séborrhéique, dermatite de contact, chimiothérapie, dysfonction thyroïdienne, auto-immune (associé à des anomalies des ongles), lichen plan, infections fongiques (tinea capitis), bactérienne, Tbc,

lèpre, virale (HZV), radiation, brûlures, lupus discoïde, morphee (coup de sabre), trichotillomanie, post-partum, hyperandrogénisme

Questions type : anamnèse familiale d'alopécie, poils, sourcils, cils, ongles, prurit, lésions cutanées, changement de shampoing, changement de couleur, plaques sur la peau, douleurs articulaires, état fébrile, état général, alimentation, perte de poids, faiblesse musculaire, quelle perte par jour, grossesse (post-partum, fausses couches), règles, signe de virilisation, symptômes d'hypothyroïdie

Exa : bulbe du cheveu présent, quantifier la touffe

Céphalées P56/57

Localisation (unilat. vs bilat.), irradiation, qualité, durée, début progressif/brutal, timing (jour/nuit), N/V, facteurs soulageant/aggravant (stress, fatigue, règles, exercice, certains aliments), intensité (0-10), pulsatilité, larmoiement, rhinorrhée, symptômes neuro (paresthésie, tr.visuels, faiblesse, parésie, ataxie, vertiges, photo-/phonophobie, dysarthrie), Valsalva dépendant, épisodes antérieurs, trauma tête, chirurgie dentaire, sinusite, épilepsie (morsure langue, perte d'urine, mouvements tonico-cloniques), claudication de la mâchoire, événement particulier/stress, sevrage caféine/nicotine, médicaments, anamnèse familiale de migraine, état grippal (myalgie/arthralgie), fièvre, lésions cutanées (rash), perte de poids, perte d'appétit, FR TVP/EP, dernières règles

DD:

- hémorragie sous-arachnoïdienne
- migraine (unilatéral, pulsatile, modérée à sévère, aggravation par activité physique simple, N/V, photo-/phonophobie)
- céphalée de tension
- céphalée en cluster (oeil rouge, larmoyant, nez bouché, rhinorrhée, sudation du visage et du front, myosis, ptosis, oedème palpébral)
- arthrite temporale
- méningite
- thrombose sinus veineux (femmes jeunes, FR: tabac, oestrogènes, obésité)
- Pseudotumeur cérébrale (femmes jeunes et obèses, céphalées bifronto-temporale initialement à prédominance matinale, oedème papillaire, PL -> augmentation de la pression du LCR)
- dissection carotidienne (HTA, symptômes visuels prodromaux, dlr cervicale/céphalée unilatérale, acouphène pulsatile, ischémie cérébrale -> inaugural ou différé, AIT/AVC, Claude-Bernard Horner (ptosis, enophtalmie, miosis, anhidrosis), paralysies dernier NC (VI, VII, IX, X, XI, XII))

Red flags: nouvelle ou différente, coup de tonnerre/ explosive, la pire, T°, HTA/hypertension maligne, claudication mâchoire, perte pondérale, rash/méningisme, déficit focal, Valsalva dépendant, céphalée inaugurale > 50ans, contexte particulier (HIV, immunosuppression, grossesse, post-partum, cancer, anti-coagulation, manipulation/trauma nuque, TC)

Exa: exa neuro (station debout/marche, nerfs crâniens, force/sensibilité, réflexes, épreuves cérébelleuses, Kernig/Brudzinski), fond d'oeil (oedème papillaire), auscultation cardiaque (souffle carotidien), auscultation pulmonaire, exa dirigé selon anamnèse (ORL (percussion des sinus), stomatologique, ATM, rachis cervical)

Work-up: FSC, CRP, VS, CT natif (hémorragie), IRM, PL, biopsie de l'artère temporale, US Doppler des carotides (DD dissection carotidienne), D-dimères

Ronflement P75

Début, progression, perte/gain de poids, céphalées matinales, somnolence diurne, OH, symptômes d'hypothyroïdie, médicaments (benzo), sentiment d'étouffement la nuit, pauses respiratoires observés par les proches, sommeil non réparateur, tr. de la concentration, nycturie, écoulement buccale, grincage de dents la nuit, diaphorèse, bouche sèche le matin

DD:

- Syndrome d'apnée du sommeil
- Goitre, hypothyroïdie
- AVC/tumeurs, poliomyélite
- Obstruction nasale
- Etat dépressif
- OH

Exa: palper thyroïde, ADP,

Work-up: TSH, polysomnographie, FSC

Mal à la gorge P80

Début, progression, irradiation, rhinorrhée, otalgie, dysphagie liquide/solide, toux, hémoptysie, sudations nocturnes, fièvre/frissons, ADP, ictère, douleurs thoraciques, dyspnée, N/V, facteurs améliorant/aggravant, céphalées, perte de poids/perte d'appétit, spray inhalateur corticoïdes, OH/tabac/drogues, changement voix, corps étranger (arête de poisson, os poulet), contagé

DD:

- Primo-infection HIV
- Candidose
- Angine (streptococcique, mononucléose)
- Néoplasie buccale
- Corps étranger

Exa: ADP, fond de gorge, exa ORL, status abdominal (hépatosplénomégalie), exa peau, auscultation pulmonaire

Work-up: laryngoscopie, anticorps HIV, Mono-test, Strepto-test

Dysphonie/aphonie/enrouement P82

Début, progression, facteurs améliorant/aggravant, dysphagie, dyspnée, effort de voix répétitifs, pyrosis, OH/tabac, symptômes d'hyperthyroïdie (agitation, irritabilité, palpitations, tremor, sudations, perte de poids sans perte d'appétit, diarrhées), symptômes d'hypothyroïdie (prise de poids, frilosité, peau sèche, bradycardie, constipation) toux, perte de poids, fièvre, sudations nocturnes, hémoptysie, exposition pollution environnementale/fumée/poussières

DD:

- Nodule/polype corde vocale
- Néoplasies pharynx/larynx
- Goitre
- Hypothyroïdie
- RGO

- Compression n.laryngé récurrent (tumeur pulmonaire de l'apex, élargissement oreillette droite sur RAA avec sténose mitrale)

Exa: ADP, palpation thyroïde, fond de gorge

Work-up: laryngoscopie, TSH, radio thorax

Perte de vision P 83/84

Début, progression, unilatéral vs bilatéral, vision floue, scotome, flash de lumière, scintillements, mouches volantes, vision nocturne, corps flottants, photophobie, douleur oculaire, larmoiement, prurit oculaire, sécrétions, syncope, céphalées, claudication de la mâchoire, palpitations, FRCV (tabac, OH, HTN, DM, cholestérol, atcd IM/AVC/AIT), paresthésies, parésie, faiblesse, tinnitus, myopie/hypermétropie/presbytie, perte de poids, perte d'appétit, faiblesse généralisée, trauma

DD:

- Glaucome à angle fermé
- Artérite temporale
- Amaurose fugace/AVC
- Détachement rétinien
- Hémorragie du corps vitré
- Névrite optique
- Thrombose la v.centrale de la rétine
- Occlusion de l'a.centrale de la rétine

Exa: reflet rouge + fond d'oeil, nerfs crâniens, réflexes pupillaires, exa neuro complet

Work-up: lampe à fente, VS

Corps flottants P87

Unilatéral vs bilatéral, flash de lumière, photophobie, douleur oculaire, rideau noir, relation sexuelle à risque, ulcère buccaux/génitaux, céphalées, trauma

DD:

- détachement corps vitré postérieur
- hémorragie du corps vitré
- détachement rétinien
- uvéite postérieure (inflammation de la choroïde => syphilis, Tbc, HSV, CMV chez l'HIV, toxoplasmose, maladie de Behçet (triade: ulcère génital, ulcères buccaux, uvéite postérieure, mélanome ou métastases)

Exa: reflet rouge + fond d'oeil, nerfs crâniens, réflexes pupillaires, exa neuro complet, acuité visuelle

Photopsia P88

Début, progression, unilatéral vs bilatéral, photophobie, corps flottants, rideau noir, céphalées

DD:

- détachement rétinien

- décollement corps vitré postérieur
- migraine avec aura

Vision double P89

DD:

binoculaire =>

- strabisme
- parésie (III,IV,VI) 2° à une ischémie, DM, tumeur, trauma, myasthénie grave, piégeage
- orbitopathie de Basedow
- ophtalmoplégie internucléaire 2° à une SEP
- infarctus tronc cérébral

monoculaire =>

- erreur de réfraction
- accumulation de mucus sur l'oeil
- kératocône
- luxation cristallin

Photophobie P90

DD:

- abrasion/ulcère de la cornée
- kératite
- glaucome à angle fermé
- iritis
- méningite/encéphalite
- migraine

Douleur oculaire P91

DD:

- fatigue oculaire
- herpes zoster
- trauma, corps étranger
- kératite
- abrasion/ulcère cornéen
- glaucome à angle fermé
- uvéite
- épisclérite/sclérite
- névrite optique

Oeil rouge P94

Couleur sécrétion (purulent=bactérien, séreux=viral, mucus=allergique), photophobie, vision floue, ADP, verres de contact, bouche sèche, douleur oculaire, asthme, rhinite, rhume de foins, rhinorrhée, relation sexuelle à risque (conjonctivite à Chlamydia), uvéite (douleurs articulaires, spondylarthrite ankylosante, arthrite psoriasique, Crohn/RCUH), algurie (maladie de Reiter), exposition poussière/pollution, céphalées

DD:

- orçet (bord franc paupière, douleur++)/chalazion (à l'int. de la paupière, moins douloureux)
- blépharite
- corps étranger/lacération
- dacryocystite/adénite
- hémorragie sous-conjonctival
- conjonctivite
- yeux secs
- pterygion
- épisclérite/sclérite
- cellulite préseptale/orbitale (diminution AV, douleur, céphalées, fièvre, érythème paupière, œdème palpébral, chemosis, ophtalmoplégie)
- kératite
- abrasion/ulcère de la cornée
- uvéite
- glaucome à angle fermé
- hyphéma (sang dans la chambre antérieure)
- hypopion (pus dans la chambre antérieure)
- endophtalmite

Exa: lampe à fente, fluorescine, test de Schirmer, ADP pré-auriculaire, sous-mandibulaire, conjonctive palpébral (follicules, papilles), vision, fond d'oeil

Work-up: cellulite (=> hospitalisation, hémoculture, CT orbite, AB iv, drainage si abcès),

Epiphora P95

DD:

- émotions, douleur
- environnement (froid, vent, pollen, déprivation de sommeil)
- ectropion, entropion, trichiasis
- conjonctivite, uvéite, kératite, corps étranger cornéen
- yeux secs (par réflexe)
- obstruction drainage lacrimonal (âge, rhinite, dacryocystite)

Exa: fluorescine dans le cul-de-sac conjonctival

Oedème palpébral P102

DD:

- allergie
- IC congestive/insuffisance rénale ou hépatique
- Congestion veineuse orbitale 2° à une masse ou à une fistule du sinus caverneux
- Dermatochalasis (âge ou héréditaire)
- Cellulite de la paupière
- Myxœdème (thyroïde)
- Trauma
- Chémosis

Gynécomastie P105

Début, progression, douleurs, qualité, localisation, unilatéral vs bilatéral, douleurs/masse testiculaire, galactorrhée, tr. visuels, dysfonction érectile, libido, prise de poids, perte d'appétit, sudations nocturnes, fièvre

DD:

- tumeur testiculaire
- idiopathique
- prolactinome
- tumeurs cérébrale
- OH/médicaments (spironolactone/digoxine)

Exa: palpation sein, exa génital

Work-up: PRL, TSH/LH, testostérone, alpha-foetoprotéine, bHCG

Dypnée P112

Début, durée, progression, facteurs améliorant/aggravant, pleurésie, douleur respiro-dépendante, toux, expectorations, hémoptysie, fièvre, rhinorrhée, sifflements, pyrosis, perte de poids, fatigue, sudations nocturnes, syncope, céphalées, vertiges, douleurs articulaires, dysphagie, OMI, dyspnée paroxystique nocturne, trauma, palpitations, douleurs thoraciques, exposition poussières/fumée, immobilisation récente, voyage en avion, douleurs MI, contraceptif oral, tabac/OH/drogues, contage, allergie

DD:

- pneumothorax
- hémothorax
- EP
- angioedème
- épiglottite
- IC congestive (OAP)
- psychogène
- augmentation pression intra-abdominal (grossesse, ascite, masse, obésité)
- décompensation BPCO
- asthme
- infectieux (pneumonie, Tbc)
- épanchement pleural
- corps étranger
- néoplasies (cancer pulmonaire)
- hyperventilation
- péricardite/myocardite
- sarcoïdose

Exa: auscultation coeur/poumon, ADP cervicales, status abdominal, status ORL, extrémités (clubbing, cyanose, oedème)

Work-up: saturation O2, radiographie thorax, ECG, FSC, VS, CRP, fonctions pulmonaires (VEMS, Tiffeneau, peak flow), gazométrie, culture expectorations

Toux P116

Début, durée, progression, intensité, facteurs aggravant/améliorant, pleurésie, localisation, expectorations, hémoptysie, pyrosis, renvois acides, régurgitation, perte de poids, fièvre, sudations nocturnes, rhinorrhée, épistaxis, sinusite (céphalées frontales), dysphagie, corps étranger, érythème noueux, arthralgies, contag, voyage, travail (exposition silice/amiante/poussière/oiseaux), symptômes d'hypo/hyperthyroïdie, tabac/OH

DD:

- pneumonie
- bronchite/trachéite/écoulement post-nasal
- tbc
- RGO
- asthme bronchique
- BPCO
- fibrose pulmonaire 1°
- médicament (IEC)
- psychogène
- néoplasies (mésothéliome, hémopathies malignes lymphoïdes, métastases pleurales, tu médiastinales)
- goitre rétrosternal
- sclérodermie, lupus, périartérite noueuse, sarcoïdose, granulomatose de Wegener
- IC congestive

Exa: ORL (fond de gorge, laryngoscopie, ADP), auscultation coeur/poumon

Work-up: radiographie thorax

Douleurs thoraciques P119

Début, progression, intensité, localisation, qualité, irradiation, contexte (exercice, postprandial, positionnel), épisodes antérieurs, facteurs améliorant/aggravant, respiro-dépendante, palpitations, sudations, syncope, toux, immobilisation récente, voyage, douleurs MI, traumatisme, pyrosis, reflux acide, régurgitation

DD:

- EP
- IM
- péricardite
- néoplasie
- pleurodynie (=douleurs rhumatismales, intercostales, non infectieuses)
- tendinite d'insertion, chondrite costale
- RGO
- dissection aortique
- pneumothorax
- pneumonie, Tbc
- douleurs fonctionnelles
- pancréatite, colique biliaire, ulcère peptique

Exa: paramètres vitaux, auscultation cardio/pulm (carotides, reflux hépato-jugulaire, oedèmes, palpation côtes), status abdo

Work-up: TA deux bras, saturation O2, radiographie thorax, ECG, FSC, CRP, VS, troponines, CK, US

Palpitations P122

Début, contexte (exercice, caféine, anxiété), intensité, fréquence, intensité, facteurs aggravant/améliorant, pleurodynie, dyspnée, vertiges, tr.visuels, localisation, symptômes d'hyperthyroïdie (perte de poids sans perte d'appétit, diarrhée, intolérance au chaud, tremor), régime alimentaire, tr. sommeil, sudations, exposition tique

DD:

- Arrhythmies (FA, flutter, Wolff-Parkinson White, TSV, Brugada, borréliose)
- Hyperthyroïdie
- Attaque de panique
- Drogues/médicaments/caféine

Exa: auscultation cardio-pulm, palper thyroïde, status digestif, extrémités (tremor), réflexes

Work-up: ECG, TSH

Sudations nocturnes P

Début, durée, sévérité, fréquence, timing, pattern, infection récente des voies respiratoires supérieures, toux, hémoptysie, pleurésie, ADP, fièvre, rash, perte de poids, prurit, symptômes d'hyperthyroïdie (agitation, irritabilité, palpitations, tremor, sudations, perte de poids sans perte d'appétit, diarrhées), diarrhée, N/V, satiété précoce, anorexie, OH, relation sexuelle à risque, contage, cycle menstruel

DD:

- Néoplasies (lymphome, leucémie,...)
- Tuberculose
- Hyperthyroïdie
- Ménopause, périménopause
- Mononucléose infectieuse
- Infection VIH

Exa: paramètres vitaux, ORL, ADP, auscultation cardio/pulm, palpation thyroïde, status abdominal (hépatosplénomégalie)

Work-up: radiographie thorax, TSH, FSC, CRP, T-spot, Mono-spot, culture expectorations, anticorps HIV

Hémoptysie P117

Infectieux (Tbc, pneumonie, bronchite, trachéite)

BPCO

EP

Dissection aortique

Sarcoïdose (hypercalcémie -> douleurs articulaires, polydipsie, polyurie, érythème noueux, uvéite)

Wegener (hématurie, épistaxis,...)

Trauma
Goodpasture

Questions type : tr. de la crase, diathèse hémorragique, hématurie, ...

Exa: rhinoscopie

Hypertension (suivi) P125

Début, traitement, compliance, dernier cō TA, état général, monitoring TA à la maison, autres symptômes associés (fatigue, céphalées, vertiges, vision floue, nausée, palpitations, DRS, dyspnée, chgt transit, urines, faiblesse, tr. du sommeil), effets secondaires des médicaments, autre problèmes, dysfonction érectile (b-bloquant), claudication vasculaire (dlrs jambes au repos/en marchant), chgt poids, appétit, DM, hypercholestérolémie, problème cardiaque, AVC/AIT, passé médical/chirurgical, histoire familiale, travail, régime alimentaire, exercice physique, alcool, drogues, tabac, anamnèse sociale, activité sexuelle, allergies

Exa: - fond d'oeil, auscultation des carotides, exa CV (palpation, auscultation), exa pulm (auscultation), abdo, extrémités (inspection, palpation pouls périphériques), exa neuro (réflexes, Babinski, sensibilité, force)

Dysphagie P129

Début, progression, intensité, solide vs liquide, facteurs aggravant/améliorant, transit, sang dans les selles, N/V, hématemèse, toux, relation sexuelle à risque, lésions caustiques/brûlures, régurgitation, sensation de boule dans la gorge, perte de poids/appétit, sudations nocturnes, fièvre, halitose

DD:

- diverticule de Zenker
- sténose de l'oesophage (radiothérapie, tumeur, corps étranger)
- tr.motilité oesophage (spasmes, achalasie, sclérodermie)
- Candidose, herpes, CMV (HIV)

Exa: fond de gorge, laryngoscopie indirecte, ADP cervicale, status abdominal

Work-up: OGD, manométrie de l'oesophage, étude au Barium

Pyrosis P135

Début, progression, intensité, périodicité, relation avec les repas, facteurs améliorant/aggravant, OH/tabac/AINS, odynodysphagie, interruption du sommeil, hématemèse, N/V, stress récent, régurgitation acide, sensation de boule dans la gorge, renvois/éructations, épigastralgie, chgt dans le transit, intolérance à l'effort, perte de poids/d'appétit, sudations nocturnes, fièvre, toux, halitose

DD:

- relaxation inappropriée du sphincter oesophagien inférieur
- sclérodermie
- Zollinger-Ellison
- hernie hiatale
- ulcère peptique
- H.pylori

- gastrite
- angine de poitrine

Exa: status abdominal, ADP cervicales, auscultation coeur/poumon

Work-up: essai avec IPP, OGD, test respiratoire à l'urée, manométrie de l'oesophage, étude au Barium

Epigastralgie P136

Début, progression, intensité, constant/intermittent, localisation, N/V, hématurie, facteurs aggravant/soulageant, pyrosis, odynodysphagie, stéatorrhée, type de nourriture qui augmente les douleurs, épisode antérieur, diarrhées, constipation, sang dans les selles, infection récente, OH/tabac/AINS, voyage récent

DD:

- ulcère peptique perforé
- ischémie mésentérique
- gastrite
- Mallory-Weiss
- RGO
- Cholecystite
- pancréatite
- cancer pancréatique
- angine de poitrine
- IM
- rupture anévrisme de l'aorte

Exa: status abdominal, Murphy, auscultation cardio-pulmonaire

Work-up: TR, FSC, endoscopie, amylase, lipase, ECG, US

Nausée/vomissement P137

Début, progression, intensité, facteurs aggravant/améliorant, hématurie, épigastralgies, douleurs abdominales, intoxication alimentaire (viande crue, oeufs, fruits de mer), constipation, diarrhées, pyrosis, vertiges, acouphènes, hypoacousie, dysarthrie, dysphagie, odynophagie, régime alimentaire, trauma crânien, photophobie, fièvre, céphalées (matinales!), perte de poids, perte d'appétit, sudations nocturnes, contagé (gastro-entérite), lithiase (biliaire, vésiculaire, rénale), date des dernières règles

DD:

- gastro-entérite, pancréatite, cholécystite, appendicite, péritonite
- néoplasie (tumeur gastrique, cérébrale, carcinome péritonéale)
- intoxication alimentaire, médicamenteuse
- trauma crânien
- vertiges
- méningite
- AVC pontique
- ulcère gastro-duodénal
- hypertension intra-crânienne

- grossesse
- acidocétose

Exa: status abdominal, épreuves cérébelleuses, Romberg, épreuve des bras tendus, fond d'oeil,

Work-up: endoscopie, CT cérébral, PL, test de grossesse

Douleurs abdominales P138

Début, intensité, localisation, irradiation, facteurs aggravant/améliorant, qualité, N/V, hématomène, sang dans les selles, relation avec les repas, constipation, diarrhées, perte de poids/appétit, sudations nocturnes, fièvre, hématurie, algurie, date des dernières règles (GEU), relation sexuelle à risque

DD:

aigu =>

- pancréatite, cholécystite, appendicite, péritonite, gastroentérite
- perforation ulcère peptique
- iléus
- ischémie mésentérique
- diverticulite
- grossesse ectopique
- torsion/rupture kyste ovarien
- rupture anévrisme de l'aorte

chronique =>

- ulcère peptique
- colique biliaire
- maladies intestinales inflammatoire
- pancréatite chronique
- ischémie mésentérique
- Mittelschmerz
- endométriose

Exa: status abdominal (Murphy, McBurney, défense et détente), loges rénales

Work-up: FSC, CRP, ASAT/ALAT/bilirubine/PAL, stix urinaire, test de grossesse, US

Diarrhée P140

Début, progression, intensité, nombre d'épisode par jour, facteurs aggravant/améliorant, couleurs, selles flottantes, ballonnements, N/V, sang dans les selles, fièvre, hématomène, prise récente d'AB, alternance constipation, douleurs abdominales, chgt en fonction des repas, symptômes d'anémie (pâleur, fatigue, palpitations), symptômes d'hyperthyroïdie (intolérance au chaud, perte de poids sans perte d'appétit, palpitations, tremor), perte de poids, perte d'appétit, sudations nocturnes, lésions cutanées (dermatite herpétiforme dans maladie coeliaque), voyage, polyurie/polydipsie (maladie coeliaque), lésions buccales/anales, douleurs articulaires, tr.visuels, anamnèse familiale maladies inflammatoires de l'intestion

DD:

- colite infectieuse (Campylobacter, Shigella, Salmonella, Yersinia, E.Coli, C.difficile)
- malabsorption (intolérance au gluten, au lactose)
- hyperthyroïdie

-

Exa: status abdominal, TR

Work-up: culture de selles, colonoscopie, anticorps anti-transglutaminase, aliments avec peu de fibres (potage, soupe, pomme de terre, carotte, poivron, melon, pamplemousse, banane, ananas)

Constipation P141

Début, progression, nombre de selles/semaine, facteurs améliorant/aggravant, dureté, effort de poussée, sensation d'évacuation incomplète, sensation de blocage ano-rectal, manoeuvres digitales de facilitation, hydratation, douleur anale, prurit anal, hémorroïdes, sang dans les selles, voyage, régime alimentaire, perte de poids/d'appétit, fièvre, sudations nocturnes, alternance diarrhées, symptômes d'hypothyroïdie (frilosité, bradycardie, peau sèche, faiblesse proximale, prise de poids), N/V, pyrosis, médicaments, stress récent, grossesse, corps étranger, paresthésie, faiblesse musculaire

DD:

- fonctionnel (apport liquidien insuffisant, immobilisation)
- colon irritable
- diverticulite sténosante
- brides, strictures
- prolapsus rectal
- médicament (fer, abus de laxatifs, opioïdes)
- obstruction (tumeur, fécalome)
- parasitose
- hypothyroïdie, DM
- grossesse
- douleurs: fissures ano-rectales, hémorroïdes, abcès péri-anal
- SEP
- Maladie de Crohn

Exa: status abdominal, TR

Work-up: colonoscopie, FSC, ASAT/ALAT/bilirubine/PAL, TSH, aliments riche en fibre (lentilles, tomates, petits pois, pommes, pruneaux, abricots, dattes et figues, pain, pâtes, riz)

Hématémèse P142

- Varices oesophagiennes
- Malaria, fièvre jaune, sepsis
- AINS, corticoïdes,
- Brûlures, corps étranger
- Trauma
- Mallory-Weiss (OH, hernie hiatale)

Questions type : OH, tabac, voyage, médicaments, symptômes B (cancer gastrique), dysphagie

Exa: TR

Sang dans les selles P147

Mélena vs sang frais, couleur/odeurs des selles, quantité, durée, symptômes associés (perte de poids/appétit, sudations, fièvre, douleurs abdominales/rectales, ténésmes, constipation/diarrhées), trauma, atcd d'épisodes similaires, colonoscopie, médicaments, pyrosis, OH/tabac/drogues, voyage (Campylobacter, Salmonella, Shigella, E.Coli, parasitose (amibes, bilharziose)), contagé, prise d'AB (C.difficile), anamnèse familiale, N/V, vaccinations, habitudes alimentaires, prolapsus rectal, mucus dans les selles, stéatorrhée, épistaxis, saignements faciles

Exa: - exa abdominal (auscultation, palpation), TR

DD:

- Méléna (émission de selles noires et nauséabondes) => ulcère gastrique/duodénal, hémorragie de varices oesophagiennes (encéphalopathie, confus ?, orienté ?), oesophagite (radique, RGO, OH, tabac, infectieux, AINS), Mallory-Weiss (OH, hernie hiatale), tumeur (estomac, colon), lymphome, Crohn, RCUH (arthralgies, érythème noueux, uvéite, ulcères buccaux, cholangite sclérosante (ictère, prurit, selles décolorées)), angiodysplasie, vasculites (périartrite noueuse)
- Rectorragies (émission de sang rouge) => hémorroïdes, uclération rectale, fissure ou fistule anale, cacinome anal ou rectal, rectite post-radique

Work-up: - Culture de selles, FSC, colonoscopie, CEA, ASP, crase, endoscopie, ASAT/ALAT/bilirubine/PAL

Dysurie P149

Début, circonstance, progression, fréquence, facteurs améliorant/aggravant, hématurie, polyurie, qualité du jet, vidange incomplète, brûlures mictionnelles, urgence mictionnelles, fièvre, sudations nocturnes, perte de poids, exposition Tbc, contagé, écoulement au niveau de la verge, sécrétions vaginales, relation sexuelle à risque, arthralgies, prurit vaginal, cycles menstruels, anxiété, stress, dépression, toux, tr.visuels

DD:

infectieux

- cystite, urétrite, prostatite, épидидymite, orchite, cervicite, vulvovaginite, Tbc

néoplasique

- rein, vessie, prostate, pénis, vagin, vulve, hyperplasie bénigne de la prostate

inflammatoire

- arthropathies séronégatives (arthrite réactive => urétrite/uvéite/arthrite), effets 2° médicaments

hormonal

- endométriose

traumatique

- cathéter, post-coital

psychogène

- tr.somatoforme, dépression, anxiété, stress

Exa: exa génital/rectal, loges rénales, exa rachis, ADP inguinales, status abdominal

Work-up: stix urinaire, culture des urines, culture sécrétions pour gonorrhée/chlamydia

Rétention urinaire P150

Début, progression, intensité, qualité du jet, hématurie, urgences, brûlures mictionnelles,

DD:

obstruction

- calcul, caillots, corsp étranger, néoplasie, hyperplasie bénigne de la prostate, sténose urétérale, phimosis, trauma verge, constipation, masse pelvienne

innervation de la vessie

- tumeur, Parkinson, hernie discale, SEP, DM

médicaments

- anticholinergique, opioïdes, antihypertenseurs, antihistaminiques, drogues psychoactives

infection

- infection urinaire, prostatite, abcès, herpès génital

Exa: palpation/percussion vessie, exa génital (écoulement au niveau du méat urétéral), TR (prostate, tonus sphincter), exa neuro (réflexes, anesthésie en selles)

Hématurie P152

Début, quelle couleur, à quel moment du jet, caillots, nombre de fois, 1er épisode, algurie, nycturie, brûlures mictionnelles, écoulement au niveau de la verge, trauma, jogging, cheval/moto, vidange incomplète, mousse ds les urines (albumine), douleurs au niveau du ventre/dos/articulation, difficulté à uriner, puissance du jet, polyurie, oedèmes, HTN, infection récente, contrôle prostate à jour, fièvre/frissons, perte de poids/d'appétit, Tbc (contage, Mantoux), céphalées, prurit/lésions cutanées sphère génitale, dyspnée, tr. du transit, sang dans les selles, atcd de lithiases urinaires/IST, N/V, médicaments, betterave, DM, HTN, cholestérol, tabac/OH/drogues, relation sexuelle protégée, travail (solvants, amines aromatiques)

DD:

- Infections urinaires, prostatite
- Lithiases
- Néoplasies (prostate, cancer vessie, rein)
- Syndrome néphritique (Berger, streptococques,...)
- Sport, effort physique (joueur ?, cheval ?)
- Rein polykystique (anamnèse familiale)
- Médicaments (rifampicin, phénytoïne, betterave, mûres)
- Porphyrie (douleurs abdo, tr. psy)
- Iatrogène (chirurgie, sonde, fistule,...)
- Hyperplasie bénigne de la prostate
- Tbc

Exa : TA (syndrome néphritique), TR (prostate !), exa génital, ADP inguinale/cervicale, auscultation cardiaque (carotides), pulmonaire

Work-up: analyse urinaire, culture d'urine, cytologie des urines, créat/urée, PSA, US rénal, cystoscopie, CT abdomen/pelvis

Dysménorrhée P163

Début, progression, intensité, localisation, qualité, facteurs aggravant/soulageant, N/V, sécrétions vaginales, saignement, douleurs abdominales, tr.transit (dyschésie), contraception, fausses couches/ avortements, accouchement, ménarche, cycles réguliers, nombre de tampons, syndrome prémenstruel, rapport sexuel, dyspareunie, Pap test, douleurs dans les seins

DD:

- endométriose
- adénomyome
- polype utérin
- anomalies utérines
- Myomes
- Kystes ovariens
- Sténose col
- Hymen non perforé
- IST
- Stérilet (cuivre)
- Corps étranger

Exa: status abdominal, spéculum, ADP inguinale

Work-up: US, stix urinaire, frottis

Douleur/masse pelvienne P164/165

Début, progression, localisation, facteurs améliorant/aggravant, qualité, irradiation, relation avec repas, régularité des cycles menstruels, N/V, tr. du transit, sang dans les selles, algurie, dysurie, urgences, pollakiurie, incontinence urinaire, dysménorrhée, ménarche, saignement vaginaux, sécrétions vaginales, dyspareunie, relation sexuelle, tr. de l'humeur, tr. du sommeil, fièvre, perte de poids/appétit, sudations nocturnes, date des dernières règles, atcd IST, accouchement/avortements/fausses couches, abus sexuel, contraception

DD:

aigüe =>

- mittelschmerz, rupture/torsion kyste ovarien, grossesse ectopique, hémorragie d'un kyste/néoplasie
- torsion d'un pédicule de myome, nécrobiose
- endométrite
- appendicite, adénite mésentérique, diverticulite, maladie intestinale inflammatoire
- colique néphrétique, cystite, pyélonéphrite

chronique =>

- endométriose, adénomyome, dysménorrhée, kystique ovarien, fibromes, prolapsus utérin
- douleur référée, rétention urinaire, néoplasies gastro-intestinales, maladies intestinales inflammatoires, constipation, colon irritable, diverticulite, hernies, dépression, anxiété, somatisation

Exa: status abdominal (Murphy, McBurney, détente, défense), TR (cul-de-sac de Douglas), TR, spéculum, ADP

Work-up: frottis vaginaux, culture, US, colonoscopie, stix urinaire, test de grossesse

Prolapsus utérin P166

Début, progression, intensité, facteurs soulageant/améliorant, incontinence urinaire (stress, toux, effort, urgence), sensation de pesanteur (diminué en position couchée), douleur dans l'aine/dos, nycturie, sensation de vidange incomplète, pollakiurie, brûlures mictionnelles, date des dernières

règles, cycles menstruels régulier, constipation chronique, toux chronique, accouchement par voie basse/fausses couches/avortements, port de charge, tabac/OH/drogues, travail, chirurgie pelvienne

DD:

- accouchement par voie basse
- âge
- diminution œstrogène (post-ménopause)
- augmentation pression intra-abdominale (obésité, toux chronique, constipation, ascite, port de charge)

Exa: exa abdomen, vaginal

Saignement vaginaux anormaux P168

Début, progression, intensité, couleur, pilule, médicaments, dysménorrhée, nombre de tampons, rapports sexuels, prurit, pertes, grossesse récente, IST, Pap test, douleurs abdominales, symptômes d'hypothyroïdie (prise de poids, bradycardie, frilosité, peau sèche), symptômes d'hyperthyroïdie (perte de poids sans perte d'appétit, intolérance à la chaleur, palpitations), date des dernières règles, N/V, hématurie, dyschésie (endométriose), dyspareunie, symptômes B, opération récente, accouchement par voie basse/avortements, tr.visuels, sensibilité des seins, galactorrhée, tr.coagulation

DD:

- Myomes/fibromes
- Polype utérin
- Adénomyomes
- Stérilet
- Trauma, abus sexuel, corps étranger
- Infection (endométrite, cervicite, vaginite, IST)
- Grossesse
- Perte de poids/exercice physique intense/stress
- Syndrome des ovaires polykystiques
- hyper/hypothyroïdisme
- prolactinome
- tr.coagulation (maladie de VonWillebrand, purpura thrombocytopénique idiopathique, leucémie,...)
- Insuffisance rénale/hépatique
- Médicaments (anticoagulants, pilule, spironolactone, stéroïdes, chimiothérapie, neuroleptiques)

Exa: abdomen, loges rénales, TR, spéculum

Work-up: FSC, ferritine, test de grossesse, TSH, FSH/LH, Pap test, US (polype, fibrome), biopsie de l'endomètre, test de grossesse

Sécrétions vaginales/prurit P169

Début, progression, couleur, odeur, prurit, érythème, saignement vaginal, algurie, hématurie, dysurie, douleurs abdominales, N/V, tr. du transit, sang dans les selles, douches vaginales, utilisation de spray, dyspareunie, saignements post-coitaux, relations sexuelles, contagé, fatigue,

perte de poids, fièvre, sudations nocturnes, régularité des cycles menstruels, ménopause, accouchement, fausses couches, contraception, Pap test

DD:

- Vulvovaginite (candidose, trichomonas, vaginose bactérienne)
- Chlamydia/Gonorrhée
- Local: irritants chimiques, douches, sprays, corps étranger, trauma, vaginite atrophique
- Néoplasie: vulve, vagin, col, endomètre
- Systémique: toxic shock syndrome, maladie de Crohn, lichen scléreux
- Stérilet, pilule
- Pediculosis pubis

Exa: inspection, spéculum, status abdominal, TR, ADP inguinales

Work-up: frottis vaginal, culture, KOH (hyphes et spores), Whiff test, stix urinaire, US

Ménopause P172

Début, progression, intensité, bouffées de chaleur, sudations nocturnes, tr. du sommeil, fourmillements, nausée, palpitations, dyspareunie, prurit vaginal, sécheresse vaginale, saignements vaginaux, pollakiurie, urgences mictionnelles, incontinence, ostéoporose, arthralgies, myalgies, douleurs dorsales, diminution taille des seins, tr. de l'humeur, irritabilité, fatigue, diminution libido, tr. de la mémoire

Exa: status abdominal, spéculum

Work-up: FSH/LH, diminution taux d'estradiol

Suspicion grossesse P175

Grossesse désirée, lien avec partenaire, date des dernières règles, symptômes d'anémie (paleur, fatigue, palpitations, intolérance à l'effort), sécrétions vaginales, saignement vaginaux, N/V, tr. du transit (constipation, diarrhée), fièvre récente, sensibilité sein ou écoulement, chgt peau, symptômes urinaires (pollakiurie, urgences, brûlures), dyspnée, céphalées, Pap test, ménarche, anamnèse familiale DM, régime alimentaire, exercice physique, tabac/OH/drogues/caféine, médicaments, prise de poids, symptômes d'hypo/hyperthyroïdie, atcd herpès/IST, grossesse antérieure/avortements/fausses couches, violences sexuelles, groupe sanguin, transfusions dans le passé

Exa: poids/taille, palpation thyroïde, cœur/poumon, abdomen, sein, exa vaginal

Work-up: test de grossesse, US pelvien, FSC, glucose, TSH, sérologie rubéole, HBsAg, anticorps HIV, VDRL, groupe sanguin, Rh, Pap test, stix et culture urinaire, frottis vaginaux

Hypertension durant la grossesse P182

Début, progression, céphalées, tr. visuels (vision floue, scotomes), tremor, irritabilité, somnolence, hyperreflexie, saignements, pétéchies, tinnitus, douleur abdominale en barre/épigastralgie, N/V, oedèmes main et visage, diurèse, chgt couleur des urines, crise d'épilepsie, évaluation du fœtus (mouvements), histoire obstétrical

DD:

- hypertension pré-existante (>140/90, < 20ème SA)
- hypertension gestationnelle (>140/90, après la 20ème SA)
- Pré-éclampsie
- syndrome de HELLP

Exa: paramètres vitaux, status abdominal, status neuro (réflexes, champs visuels, vision, épreuves des bras tendus), inspection cutanée

Work-up: Hb, plaquettes, TP/aPTT, fibrinogène, D-Dimères, ASAT/ALAT, LDH, bilirubine, protéinurie, créatinine, monitoring diurèse, US (Manning => mouvements respiratoires, CTG, tonus, quantité de liquide amniotique)

Dorsalgies P205

Début, progression, trauma, facteurs soulageant/aggravant, intensité, localisation, irradiation, douleurs nocturnes, claudication neurogène, épisode antérieur, paresthésie, faiblesse, perte de sensibilité MI ou sphère génitale, douleur électrique, perte de poids/appétit, fièvre, sudations nocturnes, perte d'urine/selles, dysurie, algurie, brûlures mictionnelles, OH/tabac/drogues (injection), toux, exposition Tbc, douleurs articulaires, lésions psoriasiques, douleurs abdominales/diarrhées (sacroïlite sur Crohn/RCUH), lithiases urinaires, DM

DD:

- Contracture musculaire
- Canal lombaire étroit
- Hernie discale
- Métastase osseuse (prostate, sein, MM)
- Spondylodiscite (infection urinaire, drogues iv)
- Mal de Pott (Tbc osseuse)
- Arthrose
- Pancréatite

Exa: exa rachis, exa neuro, Lasègue, TR, exa de la hanche

Work-up: radiographie, IRM, PSA, FSC, calcium, urée, électrophorèse des protéines sériques et urinaires

Exa nné:

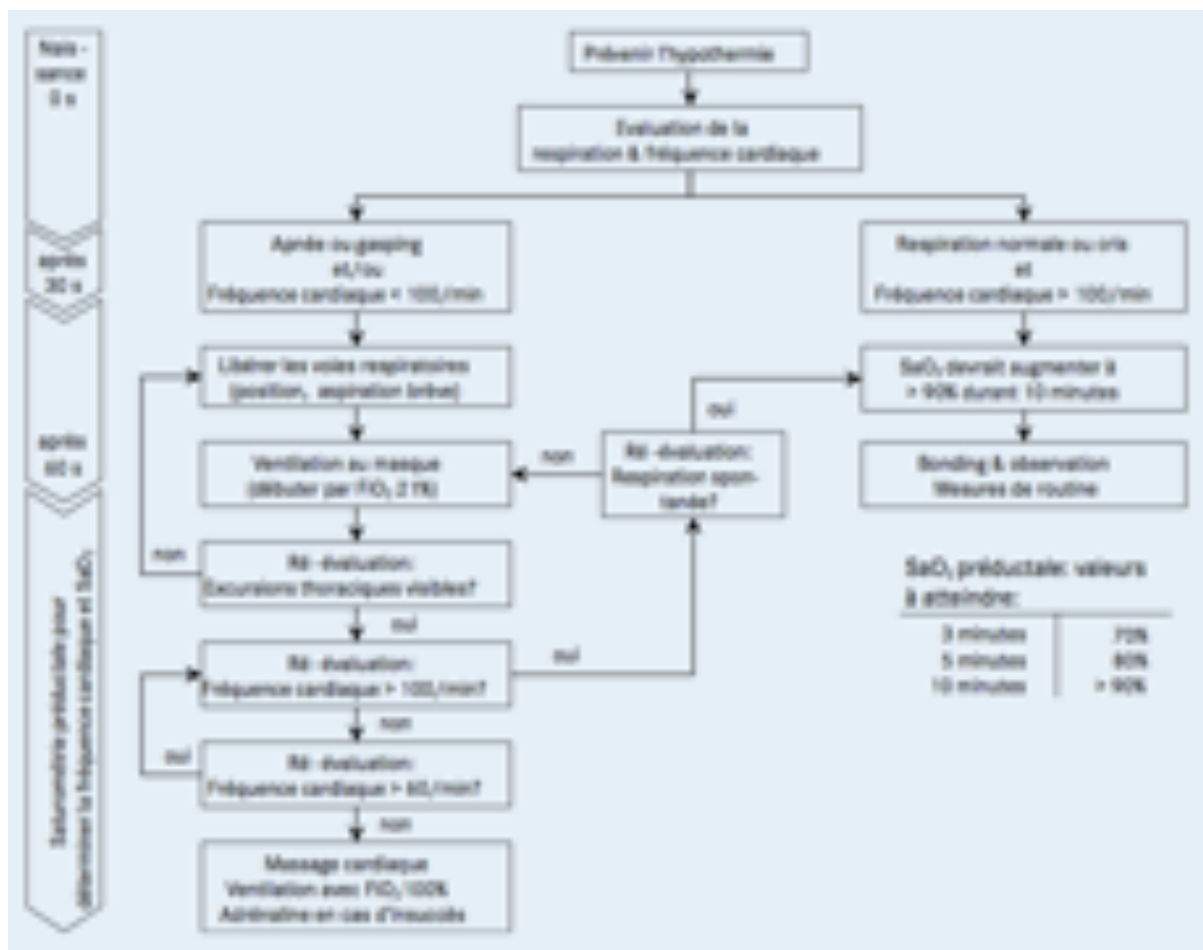
Anamnèse: déroulement de la grossesse, nné à terme (37-42SA), geste et parité, sérologie (VDRL, HbsAg, HIV, rubella), Strepto B, vit.K (4h, 4j, 4 semaines), groupe sanguin maman, liquide amniotique clair, rupture des membranes (<18h), méconium, score d'Apgar (coloration, réactivité, tonus, FC, FR), tabac/OH/drogues, allergie chez les parents, prévention (fumée, couché le bébé sur le dos, 18°C, pas trop le couvrir), allaitement, vit.D (depuis 4ème jour jusqu'à une année, 400UI), anamnèse de dysplasie de hanche dans la famille/maladie cardiaque et rénale, voyage prévu ds 6 premiers (Russie, Balkans) pour BCG

Exa: palpation fontanelle et suture, check fente palatine et réflexe de succion, check reflet rouge, implantation des oreilles, tâche de naissance/angiome, palpation des clavicules, FC (100-150), FR (40-60), palpation abdomen, pouls fémoraux, check nombre de doigts/orteils, réflexe de grasping,

test dysplasie de hanche, OGE (hypospadias), perforation anus, check dos, réflexe de galant, marche automatique, check pied bot, asymétrie longueur des MI, check nombril, lésions cutanées

Réanimation du nné:

Prise en charge: ABCs, stimulé et réchauffé, aspiration, oxygène + ventilation si apnéique ou FC<100/min, monitorer la saturation et la FC (si < 60/min, commencer les compressions => 120compressions/min, 3 compressions:1 ventilation = 90 compressions/min:30ventilations/min



DD:

- maladie des membranes hyalines
- aspiration de méconium
- pneumonie
- pneumothorax
- hydrops foetal (anémie hémolytique)
- hypothermie/hypoglycémie/infection
- DM, hypertension chez la mère
- choc/cyanose/maladie cardiaque congénitale

Enfant irritable/qui pleure P212

Début, progression, qualité, durée, facteurs aggravant/améliorant, léthargie, pattern des pleurs, tr.sommeil, diarrhée/constipation, sang dans les selles, vomissement, douleurs abdominales, algurie,

otalgies, otorrhée, rhinorrhée, toux, signe de déshydratation (absence de larme, anurie,...), toux, signe de détresse respiratoire (tachypnée, tirage, battement des ailes du nez, stridor), appétit, perte de poids, fièvre, convulsions, développement de l'enfant, vaccinations (récent?), dernier cô chez le pédiatre, voyages, contagé, trauma, alimentation au sein, prise de drogues maternels

DD:

- méningite
- otite moyenne aigüe
- invagination, volvulus
- infection des voies respiratoires
- hernie inguinale étranglée, torsion testiculaire, oedème scrotal, phimosis
- syndrome de l'enfant secoué (hémorragie rétinienne)
- sepsis

Exa: exa compét, exa génital, rectal, otoscopie, ophtalmoscopie, bombement de la fontanelle, temps de recoloration

Failure to thrive P160

Durée du problème et histoire de la croissance, progression, retard de croissance intra-utérin, déroulement grossesse, infection, alimentation, allaitement, appétit, comportement avant et après les repas, N/V, constipation/diarrhée, situation sociale, travail des parents, conflit de couple, crèche, taille et poids des parents, tempérament de l'enfant, interaction avec les parents, comportement alimentaire, stressseurs psychosociaux, atcd de trauma, développement de l'enfant (premiers pas, premiers mots)

DD:

- incapacité à se nourrir: production insuffisante de lait chez maman, RGO, vomissements, problème mécanique à avaler, anorexie
- malabsorption: maladie coeliaque, mucoviscidose, insuffisance pancréatique, diarrhée chronique
- utilisation inappropriée des nutriments: tubulopathies, DM, DI, hypothyroïdie congénitale
- augmentation des besoins: mucoviscidose, maladie cardiaque, hyperthyroïdie, DI, néoplasies, lupus
- non-organique (90%): malnutrition, nutrition inadéquate, mauvaise technique de nutrition, négligence

Exa: poids, taille, périmètre crânien, stade de Tanner, signe d'abus ou de négligence

Work-up: FSC, frottis sanguin, électrolytes, urée, VS, TSH, stix urinaire, âge osseux, caryotype,

Enurésie P218

Définition: incontinence urinaire le jour/ou la nuit chez un enfant > 5ans, > 2x/semaines, > 3mois

1° (n'a jamais été propre), 2° (a déjà été propre), associé avec incontinence anale, constipation, nombre d'épisode par semaine, développement de l'enfant (langage, marche,...), naissance (sp, poids, taille,...), vaccinations, histoire familiale d'enurésie, stress, anxiété, timidité, impact sur le fonctionnement (école, copains,...), cauchemars, somnambulisme, conflit de couple, frères/soeurs, passé médical/chirurgical, essai thérapeutique (diminution boissons le soir, alarme,...), prurit anal
Tr. somatiques (fièvre, frissons, hématurie, urines -> couleur, odeur, jet)

Exa: exa génital/abdomen

Work-up: stix et culture urinaire, gravité urinaire, US rénal

DD:

- énurésie nocturne 1°
- infection urinaire
- DM
- diabète insipide
- vessie neurogène, paralysie cérébrale
- anémie falciforme
- épilepsie
- oxyures
- constipation

Puberté précoce P223

normes => F= 8-13 ans H= 9-14 ans

Début, progression, sensibilité des seins, poils axillaires/pubiens ou ailleurs (ventre, moustache, dos), galactorrhée, sécrétions vaginales, saignements vaginaux, prurit vaginal, cycles menstruels (régularité, quantité, nombre de jour, nombre de tampons/jour), acnée, croissance, fatigue, dyspnée d'effort, prise de poids, résultats scolaires, céphalées, tr. visuels, appétit, fièvre, douleurs articulaires, dysurie, algurie, hématurie, dysménorrhée, puberté chez les parents, médicaments, tabac/OH/drogues, relation sexuelle

HEEADSSS => **H**ome **E**ducation/**E**mployment **E**ating **A**ctivities **D**rugs **S**exuality **S**uicide/
depression **S**afety

DD:

- idiopathique/constitutionnel
- tumeurs cérébrales, hamartome, post-méningite, augmentation de la pression intra-crânienne
- neurofibromatose
- hypothyroïdie 1° sévère
- hyperplasie surrénalienne congénitale, néoplasie surrénalienne
- tumeur ovarienne/testiculaire
- administration de stéroïdes exogènes
- syndrome de McCune-Albright (tâches café-au-lait)

Exa: stade de Tanner, exa génital, fond d'oeil (HTIC), exa neuro

Work-up: oestrogène, testostérone, LH, FSH, TSH, GnRh, âge osseux, +/- CT/IRM, US surrénales

Puberté retardée P223

normes => F= 8-13 ans H= 9-14 ans

Début, progression, sensibilité des seins, poils axillaires/pubiens ou ailleurs (ventre, moustache, dos), galactorrhée, sécrétions vaginales, saignements vaginaux, prurit vaginal, cycles menstruels (régularité, quantité, nombre de jour, nombre de tampons/jour), acnée, croissance, fatigue, dyspnée

d'effort, prise de poids, résultats scolaires, céphalées, tr. visuels, appétit, fièvre, douleurs articulaires, dysurie, algurie, hématurie, dysménorrhée, puberté chez les parents, médicaments, tabac/OH/drogues, relation sexuelle

HEEADSSS => **H**ome **E**ducation/Employment **E**ating **A**ctivities **D**rugs **S**exuality **S**uicide/depression **S**afety

DD:

- idiopathique/constitutionnel
- syndrome de Turner, Klinefelter
- Infection, radiation, trauma au niveau des gonades
- dysgénésie des gonades
- déficit hormonal (insensibilité aux androgènes, 5alpha-réductase)

Exa: stade de Tanner, exa génital, fond d'oeil (HTIC), exa neuro

Work-up: oestrogène, testostérone, LH, FSH, TSH, GnRh, âge osseux, +/- CT/IRM, US surrénales, caryotype

Enfant hyperactif P224

Début, progression, attention/concentration, tr. développement (âge marche, premier mots,...), capacité de se focaliser sur un jeu/activité, capacité à écouter, n'achève pas les tâches, désorganisation, nbreux oublis, capacité à créer amitié, incapacité à tenir en place, bouge tout le temps, ne peut pas jouer en silence, parle excessivement, résultats scolaires, activités sportives, interrompt la parole, manque de compassion/empathie pour autrui, impact sur le fonctionnement familial, maladies psychiatrique dans la famille

DD:

- trouble déficitaire de l'attention/hyperactivité
- retard de développement
- syndrome génétique
- encéphalopathie ou toxiques (alcool, plomb)

Paresthésie P243

Début, progression, intensité, symétrie, localisation, facteurs soulageant/aggravant, sensation de brûlures/décharge électrique/fourmillements, anesthésie en chaussettes, symptômes nocturnes, tr. de l'équilibre, vertiges, claudication neurogène/vasculaire, céphalées, douleurs nuque/dos, infection récente, TVP (voyage, immobilisation, pilule, chaleur, rougeur, tuméfaction), symptômes urinaires (faiblesse du jet, incontinence), perte de poids/appétit, fièvre, sudations nocturnes, OH, artériosclérose, HTN, symptômes neuro (dysarthrie, paresthésie, faiblesse membre,...)

DD:

- polyneuropathie périphérique (diabète, vit.B12, Guillain-Barré)
- AVC/AIT
- Sclérose en plaque
- Radiculopathie (hernie discale)
- Canal lombaire étroit
- Métastases osseuses (prostate, sein)
- TVP/EP

- Canal carpien
- Polymyosite
- Myasthénie grave (Test au Tensilon, anticorps au récepteur à l'ACh)
- Hyperventilation
- Paralysie de Todd
- Hypocalcémie (QT prolongé, crise d'épilepsie, spasme, anxieuse/irritable, tonus musculaire augmenté, dysphagie, labo: PTH, Ca, albumine, électrolytes, créat, FSC)

Exa: paramètres vitaux, exa musculo-squelettique, exa neuro complet, Babinski, touché-piqué, Lasègue, signe de Lhermitt, exa rachis

Work-up: glycémie, HbA1c, VS, calcium, vit.B12, IRM/CT cérébral, PL (analyse LCR), EMG

Vertiges P238

Etourdissements vs. vertige, environnement qui tourne (vertige périphérique) vs sensation de tangage/bateau (vertige central), perte d'audition, tinnitus, durée des épisodes, triggers (position, trauma de la tête), chute, fièvre, tr.visuels, infection des voies respiratoires, N/V, douleurs à la nuque ou trauma, médicaments, athérosclérose (IM, AVC/AIT), céphalées, irradiation, paresthésies, parésie/faiblesse, diminution de la force, palpitations, crise d'épilepsie, diplopie, médicaments (OH, antihypertenseurs, AINS, opioïdes)

DD:

- maladie de Menières (acouphènes, hypoacousie, vertiges)
- Vertiges positionnels paroxystiques bénins
- Labyrinthite
- Névrite vestibulaire
- Encéphalite
- Tumeur cérébrale
- Psychogène, post-traumatique
- Lésions cérébelleuses ou pontiques
- Migraine basilaire
- Médicaments (OH, antihypertenseurs, AINS, opioïdes)
- Hypotension orthostatique sur déshydratation

Exa: paramètres vitaux, exa neuro complet, Romberg, nystagmus, Dix-Hallpike, démarche, audition (Rinné et Weber), exa tête et cou, exa CV (carotides)

Work-up: FSC, test de Schellong, IRM cérébral

Chutes

Plainte, début, instabilité, faiblesse MI, paresthésies, vertiges, douleurs, trauma, tr.mémoire (noms, objets), aggravation, tr. visuels/auditifs, dyspnée, palpitations, douleurs rétrosternales, douleurs en ceinture, lâchage d'objet, tr. transit, incontinence (à l'effort, d'urgence), syncope, perte de connaissance, fièvre, poids, appétit, sueurs nocturnes, trauma, dépression, AVQ

DD:

- hématome sous-dural
- hydrocéphalie à pression normal
- polyneuropathie (vit. B12, DM, OH,...)
- tr.visuels/auditifs

- ostéo-articulaire /rhumato
- SNC
- démence, dépression
- hypotension orthostatique
- infection (pneumonie, infection urinaire)
- anémie, hypothyroïdie
- environnement
- ostéoporose

Entretien motivationnel

Question type:

- Est-ce que vous seriez d'accord qu'on discute un petit moment des FR pour les problèmes cardiaques?
- Qu'est-ce qui vous semble difficile en ce moment avec votre poids?
- Quelles sont les bonnes choses de la situation actuelle?
- Que voyez-vous encore?
- Imaginez que vous avez déjà pris la décision de faire quelque chose par rapport à votre poids, quels en seraient les coûts?
- Et qu'est-ce que vous verriez comme gains potentiels?
- Qu'est-ce qui serait différent si les choses changeaient?
- Si vous arriviez à changer ce comportement, qu'est-ce qui serait différent pour la suite?
- Quelle serait l'importance pour vous d'effectuer ce changement? Sur une échelle de 0 à 10, où 0 c'est pas du tout important et 10 très important, comment vous situez-vous?
- Qu'est-ce qui vous fait dire 7 plutôt que 4?
- Quoi d'autre?
- Sur une échelle de 0 à 10, si vous décidez d'effectuer ce changement, quelle serait la confiance que vous auriez en votre capacité de réussir, si 0 c'est pas du tout confiant et 10 très confiant?
- Qu'est-ce qui vous fait dire 4 plutôt que 1?
- Comment cette confiance pourrait-elle passer de 4 à 7?
- Qu'est-ce que vous allez faire?
- Que savez-vous au sujet de ...?
- Que voulez-vous savoir à propos de ... ?
- Seriez-vous d'accord que je vous explique ...?
- Qu'est-ce qui pourrait être utile pour vous?
- Ce qui est important pour vous... (valorisation)
- Si un jour vous deviez ...

Exemple alcool:

- J'aimerais vous poser quelques questions sur vos habitudes de vie: l'alimentation, le sport, le tabac et l'alcool
- Est-ce que je peux vous poser des questions sur votre consommation d'alcool?
- Dans quelles circonstances buvez-vous de l'alcool?
- Pouvez-vous me parler des bonnes choses de votre consommation? et des moins bonnes?
- Et encore?
- Donc d'un côté, voici ce que vous apporte la consommation, soit ... et d'un autre côté, voici les répercussions négatives que vous déplorez, soit ... Est-ce que je vous ai bien compris?
- Qu'en pensez-vous?
- Comment vous positionnez-vous par rapport à cela?
- Est-ce que je peux vous faire part des différentes possibilités thérapeutiques existantes? Si vous le souhaitez, je vous conseille volontiers.

- CAGE =>

1. Avez-vous déjà pensé que vous devriez peut être RÉDUIRE votre consommation d'alcool ?
2. Avez-vous déjà été AGAÇÉ par les critiques touchant votre consommation d'alcool ?
3. Avez-vous déjà éprouvé un sentiment de CULPABILITÉ ou des remords au sujet de votre consommation d'alcool ?
4. Avez vous déjà pris un verre au réveil pour calmer vos nerfs ou se débarrasser d'une gueule de bois?

Hommes : un score de deux « oui » peut indiquer un problème d'alcool actuel ou passé.

Femmes : un score d'un « oui » peut indiquer un problème d'alcool actuel ou passé

Annonce de mauvaise nouvelle

EPICES:

Environnement

Perception du patient: *Pouvez-vous nous dire ce que vous avez compris jusqu'à présent de votre situation? Quelles informations avez-vous déjà reçues ? Savez-vous pour quelle raison cet examen a été réalisé ?*

Invitation: *Qu'aimeriez-vous savoir à propos de ce qui vous arrive? Quel niveau d'information souhaitez-vous? Avez-vous plutôt besoin de beaucoup de détails sur votre situation, ou alors une image plutôt globale ?*

Connaissances: *Nous aurions voulu vous annoncer de bonnes nouvelles, mais malheureusement la situation est plus compliquée* (laisser ensuite un temps de silence pour évaluer sa réaction)

L'information doit ensuite être donnée graduellement en évaluant constamment les réactions du patient et de son entourage, en s'ajustant à leur niveau de compréhension. Une question de type: *Est-ce que vous me suivez ?* permet de s'assurer de sa compréhension.

Empathie: *Vous semblez totalement abattu par cette nouvelle et c'est tout à fait compréhensible*

Stratégies et synthèse: il est nécessaire d'évaluer avec le patient s'il est prêt pour une telle discussion, sachant qu'un plan pour la suite, aussi clair que possible, permettra de diminuer son anxiété. Comment a-t-il fait face à d'autres situations difficiles dans le passé ?) qu'au niveau du soutien extérieur dont il peut bénéficier (famille, amis, communauté religieuse, assistante sociale...). Les stratégies de traitement, qu'elles soient curatives ou palliatives, et d'accompagnement doivent être abordées pour que le patient ne se sente pas abandonné. L'ultime phase, comme pour tout autre entretien d'ailleurs, consiste en une synthèse du contenu et du vécu du temps passé ensemble. Elle se conclut par un prochain rendez- vous fixé pour pouvoir reprendre les éléments incompris et répondre aux questions qui émergent fréquemment à distance de l'annonce.